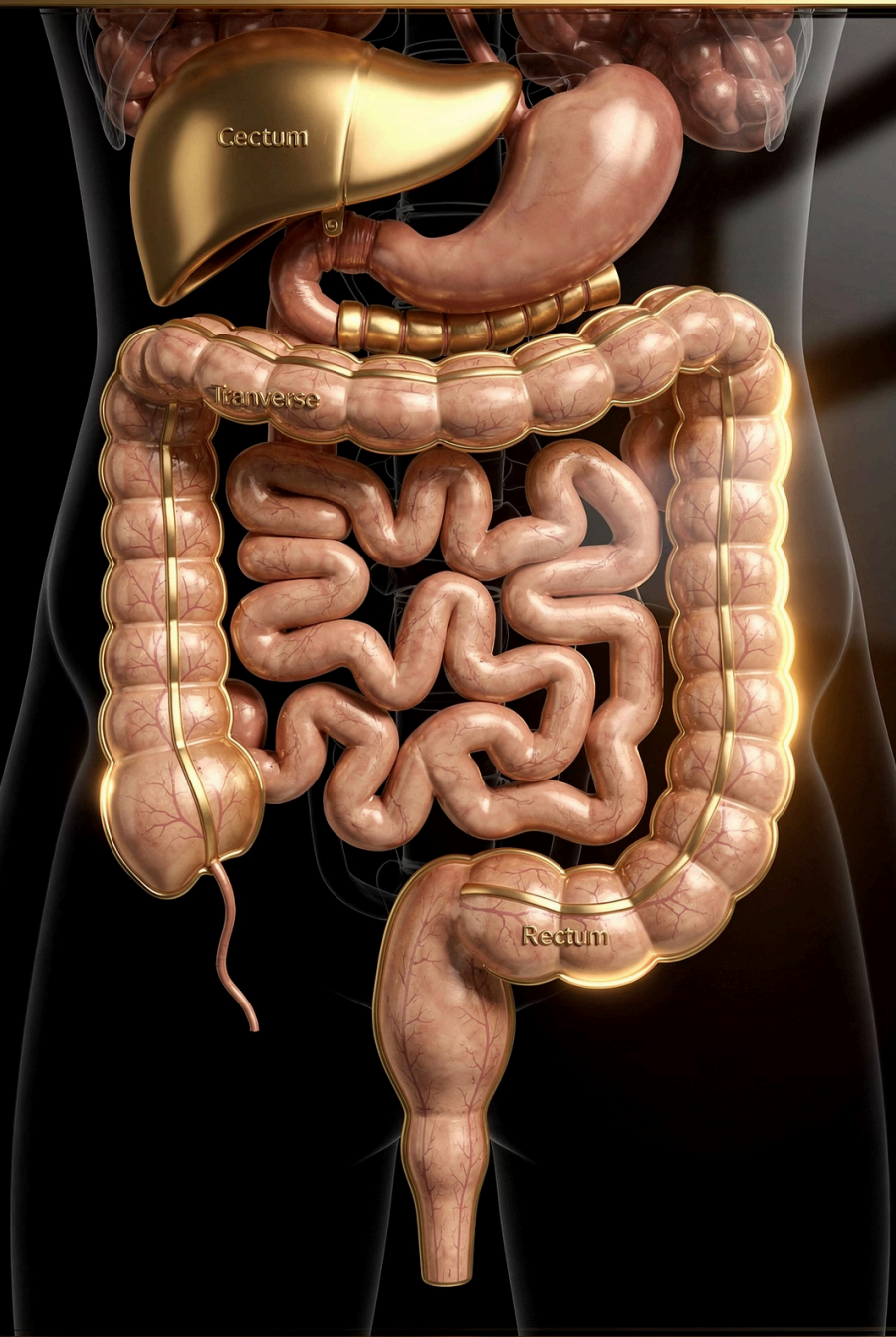




Afecções Anorretais

Complicações, Disfunções e Abordagem Clínica Final — Parte 3

Esta apostila aborda as principais condições anorretais benignas com impacto clínico significativo: prurido anal, incontinência fecal, prolapso retal e constipação intestinal. O conteúdo foi organizado para médicos em formação especializada, com ênfase em diagnóstico diferencial, fisiopatologia e condutas baseadas em evidências.

COLOPROCTOLOGIA

ESPECIALIZAÇÃO MÉDICA

PÁGINAS 41–68

Prurido Anal — Conceito e Epidemiologia

O **prurido anal** é um sintoma extremamente frequente na prática coloproctológica, caracterizado por sensação persistente de coceira na região perianal. Sua origem é classicamente **multifatorial**, podendo envolver componentes dermatológicos, infecciosos, parasitários, alimentares ou funcionais.

Em uma parcela significativa dos pacientes, não é possível identificar uma causa primária claramente definida — nesses casos, o quadro é classificado como **prurido anal idiopático**, que pode representar até 50% dos casos em séries clínicas.

📌 📌 A ausência de causa definida não exclui a necessidade de investigação criteriosa. O diagnóstico de idiopático só deve ser estabelecido após exclusão ativa de causas tratáveis.

Dados Epidemiológicos

5%

da população adulta
afetada

♂ > ♀

Predominância masculina

Alta taxa

de causas indefinidas

Principais Causas do Prurido Anal

A identificação da etiologia é fundamental para o sucesso terapêutico. As causas são diversas e frequentemente coexistentes:



Higiene Inadequada

Excesso ou déficit de higiene local leva à irritação química ou acúmulo de resíduos fecais, desencadeando o ciclo pruriginoso. Uso excessivo de papel higiênico perfumado e lenços umedecidos também são fatores relevantes.



Infecções

Fungos (*Candida spp.*), herpes simples, HPV, oxiúros (*Enterobius vermicularis*) e outros parasitas intestinais são causas infecciosas comuns, especialmente em imunossuprimidos e crianças.



Doenças Anorretais

Hemorroidas, fissuras anais e fistulas perianais causam umidade local, secreção e irritação química da pele perianal, criando substrato ideal para o desenvolvimento do prurido.

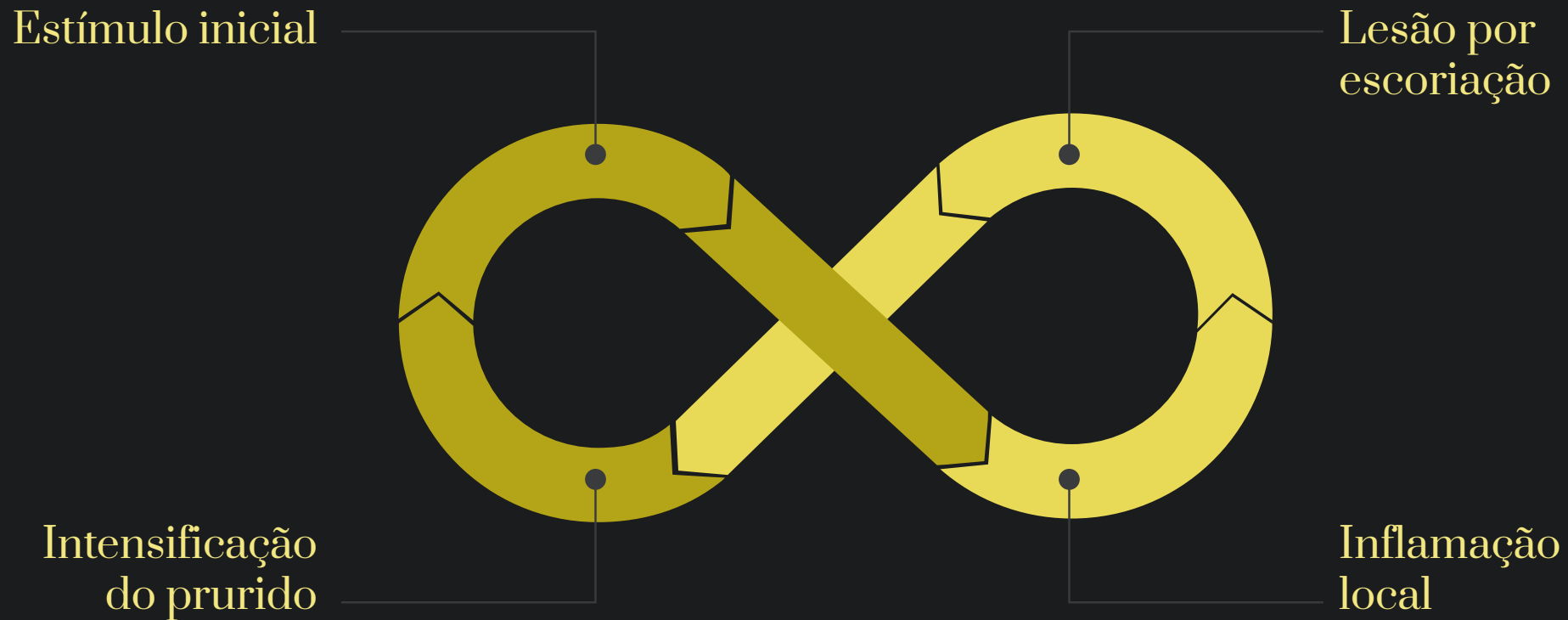


Dermatites e Neoplasias

Dermatite de contato, psoríase e líquen simples crônico são causas dermatológicas. Menos frequentemente, neoplasias como a doença de Paget perianal e carcinoma espinocelular podem se manifestar com prurido.

O Ciclo Vicioso do Prurido Anal

Compreender a fisiopatologia cíclica do prurido anal é essencial para romper o processo e tratar efetivamente o paciente. Uma vez instalado, o ciclo tende à autoperpetuação e ao agravamento progressivo.



A coceira compulsiva provoca microlesões na pele perianal, que por sua vez desencadeiam resposta inflamatória local com liberação de histamina e citocinas pró-inflamatórias. Esse processo aumenta ainda mais a sensação de prurido, perpetuando o ciclo. A intervenção terapêutica deve ocorrer em múltiplos pontos desse circuito: controle do estímulo inicial, proteção da barreira cutânea, redução da inflamação e tratamento da causa base.

Avaliação Clínica e Diagnóstico do Prurido Anal

Anamnese Dirigida

A história clínica deve ser detalhada e sistematizada, abordando os seguintes aspectos:

- **Hábitos alimentares:** Consumo de café, álcool, pimenta, chocolate e cítricos está associado à piora do prurido por irritação direta
- **Higiene perianal:** Frequência, produtos utilizados, técnica de limpeza após evacuação
- **Uso de medicamentos:** Antibióticos de amplo espectro podem favorecer candidíase; outros fármacos causam diarreia como efeito colateral
- **Histórico dermatológico:** Psoríase, eczema atópico, líquen escleroso
- **Comportamento sexual:** Relevante para ISTs como HPV e herpes

Exame Físico e Diagnóstico Complementar

O exame perianal deve ser realizado com boa iluminação, em posição adequada:

- **Inspeção:** Presença de eritema, liquenificação, lesões satélites (candidíase), lesões verrucosas (HPV), escoriações
- **Secreção:** Avaliar cor, odor e consistência; coletar material para cultura se necessário
- **Parasitas:** Pesquisa de oxiúros com fita adesiva (método de Graham), preferencialmente pela manhã

Exames Complementares

- **Anuscopia:** Avalia canal anal e hemorroidas internas
- **Parasitológico de fezes:** Série de 3 amostras
- **Colonoscopia:** Reservada para casos selecionados com suspeita de neoplasia ou doença inflamatória intestinal
- **Biópsia perianal:** Indicada em lesões suspeitas ou refratárias ao tratamento

Tratamento do Prurido Anal e Oxiuríase

Abordagem Terapêutica Geral

O tratamento deve ser sempre **direcionado à causa base**. As medidas de suporte são complementares e essenciais para romper o ciclo pruriginoso:

→ Higiene Adequada

Limpeza suave após evacuação com água morna. Evitar sabonetes perfumados, lenços com álcool ou qualquer produto irritante na região perianal.

→ Proteção da Barreira Cutânea

Manter a região seca e protegida. Uso de pomadas com óxido de zinco ou corticosteroides tópicos de baixa potência em curto prazo para controle da inflamação aguda.

→ Medidas Comportamentais

Evitar roupas íntimas sintéticas ou muito apertadas. Preferir roupas de algodão. Não coçar. Manter unhas curtas e limpas, especialmente em crianças.

Oxiuríase (Enterobíase)

Causada pelo *Enterobius vermicularis*, é a parasitose mais frequentemente associada ao prurido anal noturno em crianças e adultos jovens.

Tratamento Específico

- **Mebendazol** 100 mg dose única, repetir após 2 semanas
- **Albendazol** 400 mg dose única como alternativa
- Tratar **todos os conviventes** simultaneamente
- Higienizar roupas de cama e roupas íntimas com água quente
- Controle ambiental rigoroso para evitar reinfecção

Incontinência Fecal — Definição e Impacto Clínico

A **incontinência fecal (IF)** é definida como a **perda involuntária e recorrente de fezes líquidas ou sólidas** pelo ânus em momento e local socialmente inapropriados. Representa uma das condições mais estigmatizantes da prática clínica, frequentemente subdiagnosticada por constrangimento do paciente em relatar o sintoma.

1/3

Mulheres acima de 65 anos

com algum grau de incontinência fecal
relatado

50%

Subdiagnóstico estimado

pacientes não relatam espontaneamente ao
médico

2–3x

Mais frequente em mulheres

em comparação a homens na população geral

O impacto social é devastador: isolamento, depressão, perda de autonomia, afastamento do trabalho e prejuízo nas relações interpessoais são consequências comuns. O médico deve abordar o tema ativamente durante a consulta, sem aguardar relato espontâneo do paciente.

Causas e Diagnóstico da Incontinência Fecal

Etiologia da Incontinência Fecal

A continência fecal é mantida por um complexo mecanismo envolvendo esfíncter anal interno (involuntário), esfíncter anal externo (voluntário), musculatura do assoalho pélvico e sensibilidade retal. Comprometimentos em qualquer desses componentes podem causar IF:

Lesões Musculares

Trauma obstétrico (lacerações de 3º e 4º graus), cirurgias anorretais prévias (hemorroidectomia, fistulotomia), traumas perineais

Causas Neurológicas

Diabetes mellitus (neuropatia autonômica), esclerose múltipla, lesão medular, AVC, neuropatia do pudendo por parto prolongado

Diarreia Crônica

Doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, colite ulcerativa — volume e consistência das fezes sobrecarregam o mecanismo continente

Prolapso Retal e IF

O prolapso crônico leva à distensão esfíncteriana e dano neurológico progressivo, resultando em incontinência associada

Investigação Diagnóstica

A avaliação deve ser sistemática e progressiva, partindo da clínica para os exames complementares mais especializados:

- **Avaliação clínica detalhada:** Escala de Wexner (Jorge-Wexner) para quantificar severidade da IF; escores de 0 (continente) a 20 (incontinente total)
- **Manometria anorretal:** Avalia pressão de repouso (EAI) e pressão de contração voluntária (EAE); identifica defeitos funcionais com precisão
- **Ultrassom endoanal (USE):** Padrão ouro para avaliação anatômica dos esfíncteres; detecta defeitos estruturais com excelente resolução
- **Defecografia:** Avalia dinâmica evacuatória; útil quando há suspeita de prolapso oculto ou retocele
- **Estudos neurológicos:** Latência do nervo pudendo; eletroneuromiografia em casos selecionados
- **Colonoscopia:** Indicada para exclusão de causas colônicas quando há diarreia associada

Tratamento da Incontinência Fecal

O tratamento da incontinência fecal deve ser **escalonado e individualizado**, considerando a etiologia, o grau de comprometimento funcional, a presença de defeito esfinteriano anatômico e as condições clínicas do paciente.



1ª Linha — Medidas Conservadoras

Regulação do hábito intestinal (evitar diarreia e obstipação extrema), ajuste dietético, antidiarreicos (loperamida) quando necessário, higiene perianal adequada e uso de protetores absorventes.



3ª Linha — Neuromodulação Sacral

A neuromodulação sacral (NMS) é indicada para pacientes com IF refratária ao tratamento conservador, inclusive na ausência de defeito esfinteriano estrutural. Estimulação elétrica das raízes S2–S4 melhora a função neuromuscular do assoalho pélvico.



2ª Linha — Fisioterapia e Biofeedback

A fisioterapia do assoalho pélvico e o biofeedback anorretal são pilares do tratamento conservador ativo. O biofeedback utiliza sensores de pressão para ensinar ao paciente a contrair voluntariamente o EAE, com taxas de melhora de 50–80% em pacientes selecionados.



4ª Linha — Cirurgia

Esfincteroplastia (sobreposição anterior) indicada em defeitos esfinterianos bem delimitados, especialmente pós-obstétricos. Colostomia em casos refratários graves com impacto importante na qualidade de vida do paciente.

Prolapso Retal — Conceito e Epidemiologia

O **prolapso retal** é definido como a **exteriorização de todas as camadas da parede retal através do ânus**, formando uma massa exteriorizada de aspecto anular com pregas mucosas concêntricas características. Deve ser diferenciado do prolapso mucoso (apenas mucosa) e das hemorroidas prolapsadas.

Epidemiologia e Perfil do Paciente

- Mais comum em **mulheres acima de 60 anos** (relação F:M de 6:1 na faixa etária idosa)
- Em homens, ocorre em faixas etárias mais jovens, frequentemente associado a doenças neurológicas
- Associação frequente com **multiparidade e parto vaginal**
- Pode coexistir com cistocele, retocele e enterocele — disfunção global do assoalho pélvico
- Incidência subestimada pelo constrangimento do paciente em relatar o sintoma

Sintomas Característicos

Massa exteriorizada

Especialmente ao esforço evacuatório, tosse ou ortostatismo prolongado

Sangramento e muco

Por ulceração da mucosa prolapsada exposta ao atrito e ressecamento

Incontinência fecal

Por distensão crônica do esfíncter e neuropatia do pudendo associada

Sensação de peso

Desconforto pélvico e sensação de evacuação incompleta frequentes

Prolapso Retal — Causas, Diagnóstico e Tratamento

Fisiopatologia e Causas

O prolapso resulta de **falência dos mecanismos de fixação retal** e fraqueza do suporte pélvico. Os principais fatores envolvidos incluem:

- **Aumento da pressão intra-abdominal crônica:** Esforço evacuatório repetido, tosse crônica, obesidade, ascite
- **Fraqueza do assoalho pélvico:** Danos musculares e fasciais por trauma obstétrico, envelhecimento, desnutrição
- **Doenças neurológicas:** Lesão medular, síndrome de Cauda Equina, neuropatia do pudendo — comprometem o tônus esfinteriano basal
- **Anatomia predisponente:** Retossigmoide redundante, mesentério longo, diastase dos elevadores do ânus

Diagnóstico

O diagnóstico é eminentemente **clínico**, realizado pela visualização direta da massa anular exteriorizada com pregas circunferenciais ao esforço. Avaliação do tônus esfinteriano, manometria e ultrassom endoanal complementam a investigação pré-operatória.



Tratamento Cirúrgico

O tratamento do prolapso retal completo é **predominantemente cirúrgico**. A escolha da técnica depende da condição clínica do paciente, presença de incontinência associada e preferência do serviço:

Via Abdominal (Retopexia)

Fixação do reto ao promontório sacral com ou sem ressecção do retossigmoide. Pode ser realizada por laparotomia ou videolaparoscopia. Menores taxas de recidiva (5–10%).

Via Perineal (Altemeier)

Ressecção perineal do reto prolapsado com anastomose coloanal. Indicada para pacientes idosos com alto risco cirúrgico. Maiores taxas de recidiva (10–30%).

Procedimento de Delorme

Mucosectomia com plicatura da muscular própria. Via perineal, menos invasivo. Indicado em prolapsos de menor extensão ou pacientes fragilizados.

Constipação Intestinal — Definição e Relevância Clínica

A **constipação intestinal** é definida pelos **critérios de Roma IV** como a presença de dois ou mais dos seguintes sintomas por pelo menos 25% das evacuações nos últimos 3 meses: fezes em cíbalos ou muito endurecidas, esforço evacuatório excessivo, sensação de evacuação incompleta, sensação de obstrução/bloqueio anorretal, necessidade de manobras manuais para evacuar, ou menos de 3 evacuações espontâneas por semana.

20%

Prevalência global

da população adulta com critérios de constipação crônica

3x

Mais frequente em mulheres

relação feminino:masculino na constipação funcional

↑ 65+

Idosos mais afetados

prevalência sobe para 30–40% acima dos 65 anos

A constipação está fortemente relacionada a fatores socioeconômicos, nível educacional, sedentarismo, dieta pobre em fibras e uso de múltiplos medicamentos. Representa um dos principais motivos de consulta em gastroenterologia e coloproctologia, com impacto relevante na qualidade de vida.

Causas da Constipação — Primárias e Secundárias

A classificação etiológica é fundamental para orientar a investigação e o tratamento. A constipação pode ser **primária (funcional)** ou **secundária a causas orgânicas identificáveis**.

Causas Primárias (Funcionais)

Trânsito Colônico Normal

Forma mais comum. Frequência evacuatória normal aos estudos objetivos. Percepção subjetiva de constipação, frequentemente relacionada a consistência das fezes e esforço. Boa resposta a fibras e hidratação.

Trânsito Colônico Lento

Redução da motilidade colônica com tempo de trânsito prolongado. Mais comum em mulheres jovens. Evacuações raras (1–2x/semana ou menos). Pode estar associada a neuropatia entérica.

Disfunção do Assoalho Pélvico

Incapacidade de relaxar o puborectal e EAE durante o esforço evacuatório (anismo/dissinergia). Sensação de bloqueio. Diagnóstico por manometria e defecografia. Biofeedback é o tratamento de escolha.

Causas Secundárias (Orgânicas)

- **Medicamentos:** Opioides (causa mais frequente em hospitalizados), antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, anticolinérgicos, suplementos de ferro, antácidos com alumínio, bloqueadores de canal de cálcio
- **Endócrino-metabólicas:** Hipotireoidismo, diabetes mellitus (neuropatia autonômica), hipercalcemia, hipomagnesemia, uremia
- **Neurológicas:** Doença de Parkinson, esclerose múltipla, lesão medular, doença de Hirschsprung (adultos jovens)
- **Obstrutivas:** Neoplasia colorretal — **sempre investigar** constipação de início recente em adultos acima de 50 anos
- **Psiquiátricas:** Depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, anorexia nervosa

❏ ⚠ Sinais de alarme: sangramento retal, perda de peso, febre, constipação de início recente após os 50 anos — indicam colonoscopia prioritária.

Fisiologia da Evacuação e Classificação Funcional

Mecanismo Normal de Evacuação

A evacuação é um processo neuromuscular complexo e coordenado que envolve múltiplos componentes:

01

Acúmulo e Distensão Retal

Fezes chegam ao reto por propulsão colônica. A distensão retal ativa mecanorreceptores que desencadeiam o reflexo inibitório retoanal (RIRA), relaxando o EAI e permitindo a "amostragem" do conteúdo retal.

02

Sensação e Decisão Consciente

O córtex cerebral interpreta os sinais de urgência. O indivíduo decide evacuar ou adiar. O adiamento repetido leva à adaptação retal e perda da sensação de urgência — importante fator na constipação funcional.

03

Coordenação Neuromuscular

Contração da musculatura abdominal e do diafragma (manobra de Valsalva), relaxamento coordenado do puborectal e do EAE, aumento do ângulo anorretal, propulsão das fezes. Qualquer falha nessa sequência resulta em constipação.

Classificação Funcional

A classificação da constipação por tipo de disfunção tem implicações terapêuticas diretas:

Tipo	Característica Principal
Trânsito normal	Percepção subjetiva, sem alteração objetiva do trânsito
Trânsito lento	Motilidade colônica reduzida, evacuações muito espaçadas
Disfunção pélvica	Anismo/dissinergia, bloqueio funcional na defecação
Forma mista	Combinação de trânsito lento + disfunção pélvica

Fatores Moduladores

- **Dieta:** Baixo consumo de fibras reduz volume e acelera trânsito inadequado
- **Hidratação:** Desidratação resseca as fezes
- **Microbiota:** Disbiose afeta produção de ácidos graxos de cadeia curta e motilidade
- **Sistema nervoso entérico:** Alterações na sinalização serotoninérgica comprometem a motilidade

Tratamento da Constipação — Medidas de Base

O tratamento da constipação funcional deve ser iniciado sempre pelas **medidas não farmacológicas**, que constituem a base de qualquer abordagem terapêutica efetiva. Essas intervenções têm evidência sólida e são seguras para uso a longo prazo.



Aumento do Consumo de Fibras

Meta de **25–35 g de fibras/dia** para adultos. Fibras solúveis (aveia, psyllium, maçã) aumentam a viscosidade do bolo fecal e servem de substrato para a microbiota. Fibras insolúveis (farelo de trigo, vegetais folhosos) aumentam o volume e aceleram o trânsito intestinal. O aumento deve ser gradual para evitar flatulência e distensão abdominal.



Hidratação Adequada

Ingestão mínima de **1,5 a 2 litros de água/dia**. A desidratação é causa frequente e reversível de constipação, especialmente em idosos que têm redução da sensação de sede. Água morna em jejum pode estimular o reflexo gastrocólico e facilitar a evacuação matinal.



Atividade Física Regular

Exercício aeróbico moderado (caminhada, natação, ciclismo) por **30 minutos, ao menos 5 dias por semana**, estimula a motilidade colônica por mecanismos neurais e hormonais. Sedentarismo é um dos principais fatores de risco modificáveis para constipação crônica.

Tratamento Medicamentoso da Constipação

Quando as medidas não farmacológicas são insuficientes, o tratamento medicamentoso deve ser introduzido de forma **escalonada e racional**, com escolha do agente baseada no mecanismo fisiopatológico predominante.

1

Agentes Formadores de Bolo Fecal

Psyllium, metilcelulose, policarbofila cálcica. Fibras solúveis que absorvem água e aumentam o volume fecal. São a primeira opção medicamentosa por segurança e tolerabilidade. Devem ser tomados com grande quantidade de água. Efeito em 2–4 dias de uso regular.

2

Laxantes Osmóticos

Polietilenoglicol (PEG), lactulose, sorbitol, hidróxido de magnésio. Retêm água na luz intestinal por osmose, amolecendo as fezes. PEG é considerado primeira linha pela eficácia e segurança comprovadas. Lactulose pode causar flatulência. Seguros para uso prolongado quando necessário.

3

Laxantes Estimulantes

Bisacodil, picossulfato de sódio, sena (senosídeos). Estimulam diretamente a motilidade colônica por ação nos plexos mioentéricos. Uso intermitente preferível ao contínuo para evitar dependência e melanose coli (depósito de pigmento — benigno, mas indicativo de uso crônico).

4

Novos Agentes Pró-Motilidade

Prucaloprida (agonista seletivo 5-HT₄): estimula motilidade colônica de alta amplitude. Indicada em constipação refratária, especialmente em mulheres. **Linaclotida e plecanatida** (agonistas da guanilato ciclase-C): aumentam secreção intestinal e trânsito. Indicadas também na SII com constipação predominante.

Medidas Comportamentais e Reeducação Intestinal

Reeducação do Hábito Evacuatório

As medidas comportamentais são frequentemente subestimadas mas têm impacto significativo no tratamento da constipação funcional, especialmente nas formas leves a moderadas:

Não Adiar a Evacuação

O adiamento repetido da evacuação suprime o reflexo evacuatório, levando à adaptação retal e piora progressiva da constipação. O paciente deve ser orientado a atender ao estímulo evacuatório assim que surgir, especialmente pela manhã.

Postura Adequada no Vaso

A posição de cócoras é a mais fisiológica para a evacuação, pois aumenta o ângulo anorretal e facilita o relaxamento do puboretal. O uso de um apoio para os pés (banquinho de 20–30 cm) simula essa posição e pode reduzir significativamente o esforço evacuatório e o tempo no banheiro.

Rotina Regular

Estabelecer um horário fixo para tentar evacuar, preferencialmente 20–30 minutos após o café da manhã, aproveitando o reflexo gastrocólico. Tempo máximo de 5–10 minutos no banheiro — evitar leitura e uso de celular que prolongam o esforço.



📌 🧘 A combinação de ajuste postural + biofeedback para dissinergia do assoalho pélvico demonstra taxas de sucesso de 70–80% em estudos controlados, superando o tratamento laxativo isolado.

Visão Integrada das Afecções Anorretais

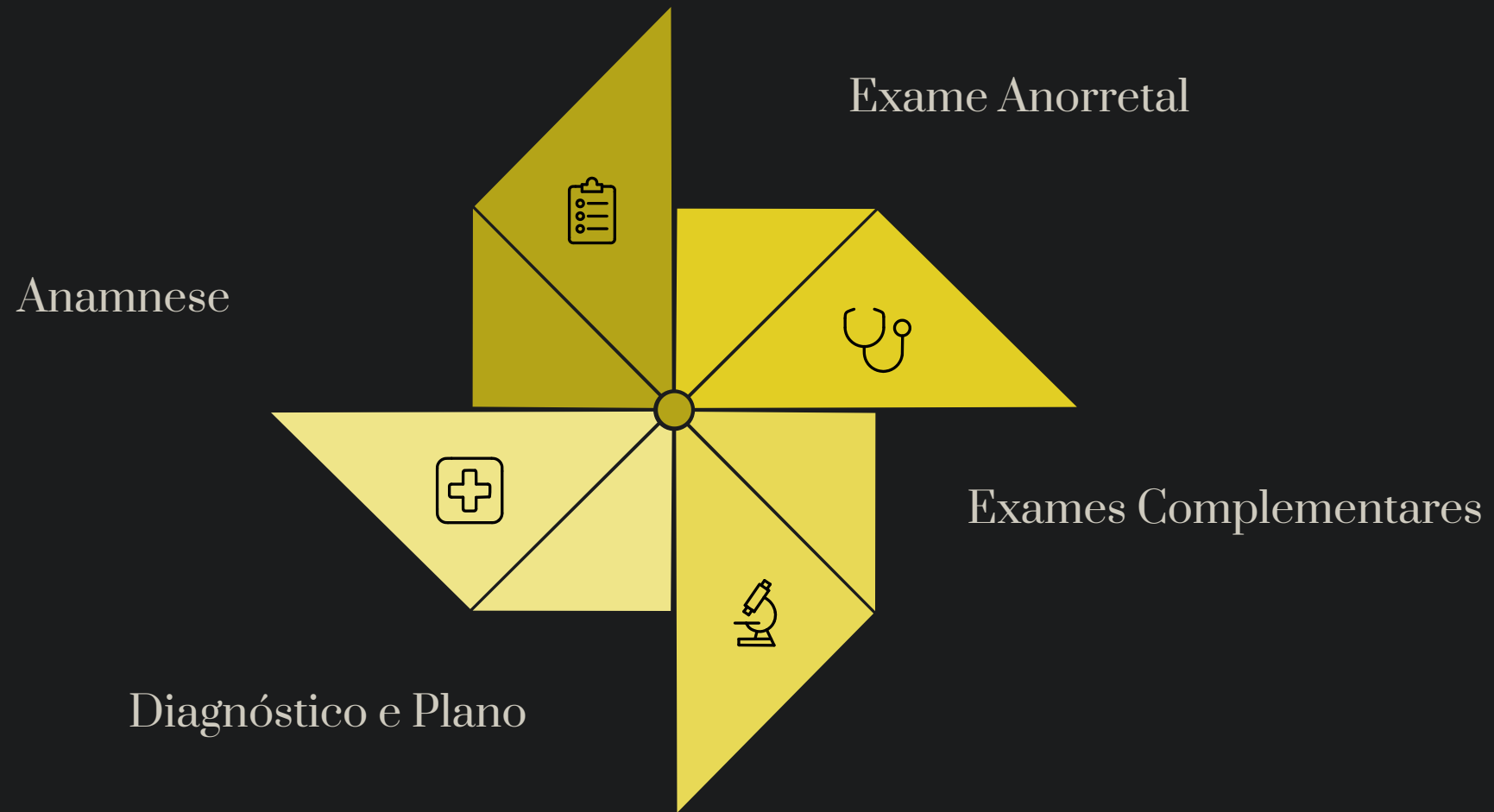
As condições abordadas nesta apostila frequentemente se inter-relacionam e compartilham mecanismos fisiopatológicos comuns. Compreender essas conexões é essencial para uma abordagem terapêutica integral e eficaz.



A constipação crônica com esforço evacuatório excessivo predispõe ao prolapso retal e às lesões esfinteranas. O prolapso retal leva à incontinência fecal por dano esfinteriano progressivo. A incontinência fecal causa prurido anal por contato crônico de fezes com a pele perianal. Reconhecer essas conexões permite ao médico tratar o paciente de forma sistêmica, e não apenas o sintoma isolado que motivou a consulta.

Abordagem Diagnóstica Integrada — Algoritmo Prático

A seguir, um roteiro diagnóstico prático para as principais queixas anorretais na consulta especializada, com base nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e recomendações internacionais:



● Sinais de Alarme

- Sangramento retal volumoso
- Perda de peso involuntária
- Constipação de início recente após 50 anos
- Massa palpável
- Anemia ferropriva inexplicada

● Investigação Prioritária

- Colonoscopia obrigatória diante de sinais de alarme
- Manometria anorretal para IF e constipação funcional
- Ultrassom endoanal para IF com suspeita de defeito estrutural

● Conduta Conservadora

- Iniciar sempre com medidas não farmacológicas
- Escalonar tratamento conforme resposta
- Reavaliação em 4–6 semanas
- Encaminhar para cirurgia quando indicado

Pontos-Chave e Referências

Síntese Final — Apostila 3 (Páginas 41–68)

Prurido Anal

Multifatorial, frequentemente idiopático. Ciclo vicioso autoperpetuante. Tratar causa base + higiene + proteção da barreira cutânea. Excluir parasitas, infecções e neoplasias.

Incontinência Fecal

Subdiagnosticada e incapacitante. Investigação com manometria e USE. Tratamento escalonado: conservador → biofeedback → neuromodulação → cirurgia.

Prolapso Retal

Exteriorização de todas as camadas retais. Diagnóstico clínico. Tratamento cirúrgico: retopexia (via abdominal) ou Altemeier/Delorme (via perineal).

Constipação Intestinal

Crterios Roma IV. Classificação funcional orienta tratamento. Base: fibras + hidratação + atividade física. Farmacológico escalonado. Biofeedback para dissinergia.

Referências Bibliográficas

- Sociedade Brasileira de Coloproctologia — Diretrizes e Consensos em Afecções Anorretais
- Bharucha AE et al. *American Gastroenterological Association Technical Review on Constipation*. Gastroenterology, 2013.
- Wald A et al. *ACG Clinical Guideline: Management of Benign Anorectal Disorders*. Am J Gastroenterol, 2021.
- Drossman DA. *Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features, and Rome IV*. Gastroenterology, 2016.
- Jorge JMN, Wexner SD. *Etiology and management of fecal incontinence*. Dis Colon Rectum, 1993.